

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076383-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ISAQUE FERNANDES PERES

RECORRENTE: MARIO CESAR DA SILVA PERES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DO RIO GRANDE

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS TAMANHO P ADULTO. AUTOR, MENOR, PORTADOR DE MIELOMENINGOCELE, HIDROCEFALIA, BEXIGA NEUROGÊNICA E EPILEPSIA FOCAL. DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS PARA SE LOCOMOVER E REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES. INSUMOS INDICADOS E NECESSÁRIOS AO QUADRO CLÍNICO, CONFORME PARECER DO NAT. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. QUALIDADE DE VIDA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO para que os Réus, dentro de suas esferas de competências e observado o tema 793 do STF, forneçam ao Autor fraldas descartáveis adulto tamanho P, conforme prescrição médica do evento 1, ANEXO2, fl. 14). Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5076383-22.2024.4.02.5101

510014666163 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076383-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ISAQUE FERNANDES PERES

RECORRENTE: MARIO CESAR DA SILVA PERES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DO RIO GRANDE

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que deferiu parcialmente a tutela nos seguintes termos (evento 15, DESPADEC1):

*"ISAQUE FERNANDES PERES, menor impúbere representado nos autos por seu genitor, MÁRIO CÉSAR DA SILVA PERES, propõe ação pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de tutela de urgência, em face da **UNIÃO FEDERAL**, do **ESTADO DO RIO DE JANEIRO** e do **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, objetivando o fornecimento de fraldas descartáveis e dos medicamentos Clobazam e Oxcarbazepina, ante diagnóstico de epilepsia focal (CID 10 Q079).*

Parte autora patrocinada pela DPU.

Petição inicial instruída com documentos (ev. 1, inic1).

Termo de renúncia do montante que exceder 60 salários mínimos (ev. 1, anexo2, fl. 10).

Decisão concedendo a gratuidade de justiça e intimando o NAT para apresentar parecer em 72h (ev. 4).

Decisão renovando a intimação do NAT (ev. 10).

É o breve relatório. Decido.

Por duas vezes, o núcleo técnico deixou transcorrer o prazo sem apresentar o parecer. Em que pese sua importância, trata-se de pleito de urgência, razão pela qual passo a apreciá-lo.

É o relatório. Decido.

Em relação à tutela provisória de urgência, a questão demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito (*fumus boni juris*) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*), tudo na forma do art. 300 do CPC.

Nos termos do art. 196 da CF/88, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Embora haja controvérsias acerca dos limites do direito à saúde, sobretudo no que tange à possibilidade de fornecimento de tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, tratamentos experimentais ou procedimentos a serem realizados no exterior, o fato é que, uma vez incorporado o tratamento/procedimento/medicamento pleiteado na cobertura do SUS, não cabe à Administração Pública furtar-se do seu dever de fornecer o tratamento, sob pena de descumprimento de normas vinculantes editadas pela própria Administração.

Nessa linha, veja-se que a vinculação da Administração Pública ao fornecimento de assistência integral à saúde em relação a procedimentos incorporados ao Sistema Único de Saúde decorre não apenas de interpretação do art. 196 da CF/88, mas, também, da leitura do art. 6º, inciso I, alínea “d”, c/c art. 19-M, inciso I, da Lei nº 8.080/90, que estabelecem o seguinte:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em:

I- dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravamento à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.”

Em relação ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp nº 1.657.156/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 106), fixou a seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

Pois bem.

In casu, conforme formulário médico emitido em 29/05/2024 pela Dra. Hanid Fontes Gomes (CRM 5290104-0), neurologista pediátrica do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteria - IPPMG, o autor possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, mielomeningocele e hidrocefalia, além de apresentar bexiga neurogênica e **epilepsia focal** (ev. 1, anexo2, fls. 13/19).

Para controlar os ataques epiléticos, o paciente faz uso de **Oxcarbazepina**, droga antiepilética que possui boa segurança no uso em crianças (baixa frequência de efeitos colaterais), associada a **Clobazam**, para sinergismo e melhor resposta (ev. 1, anexo2, fl. 12).

A médica ainda registra que o autor não possui controle esfinceteriano e por isso faz uso de **fraldas tamanho P de adulto** (ev. 1, anexo2, fl. 13).

Muito embora o Núcleo Técnico ainda não tenha se manifestado nestes autos, apesar de duas vezes intimado para tanto (ev. 4 e 10), em consulta ao processo nº 5009125-54.2022.4.02.5104, que tramita na 1ª VF de Volta Redonda, verifica-se que o referido órgão emitiu parecer recente,

em 29/05/2024, sobre o Clobazam, também num caso de paciente com epilepsia, manifestando-se da seguinte forma (ev. 162 daqueles autos):

1. Em prévio PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 1291/2022, elaborado em 17 de novembro de 2022 (Evento 21_PARECER1, Páginas 1 a 9), no item 8 da Conclusão, este Núcleo recomendou avaliação médica quanto a possibilidade de prescrição dos medicamentos disponibilizados no SUS para o tratamento da Epilepsia.

2. Neste sentido, foi acostado ao processo novo documento médico (Evento 109_ANEXO1, página 2). No referido documento médico a médica assistente detalha o quadro clínico da Autora e elenca medicamentos utilizados em seu plano terapêutico.

3. Assim, **reitera-se os medicamentos Clobazam 20mg (Frisium®), Lacosamida 50mg (Lacotem®) e Levetiracetam 100mg/mL (Keppra®) e o insumo fralda descartável infantil (tamanho G) estão indicados ao manejo do quadro clínico e comorbidades apresentadas pela Autora - epilepsia, conforme relato médico.**

(...)

9. No que tange à disponibilização pelo SUS dos medicamentos e produtos pleiteados, insta mencionar que:

* Lacosamida 50mg (Lacotem®), Canabidiol 50mg/mL Prati Donaduzzi® e fralda descartável infantil (tamanho G) não integram nenhuma lista oficial de medicamentos/produtos/insumos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado), não cabendo seu fornecimento em nenhuma esfera do SUS.

*** Clobazam 20mg - Faz parte das linhas de cuidado preconizadas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para epilepsia, estando elencado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) como grupo 2. Conforme disposto no art. 49 do Título IV da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelece as normas de execução do CEAF no âmbito do SUS, cabe às Secretarias de Saúde dos Estados e ao Distrito Federal a programação, aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos que compõem o grupo 2, desde que garantidas as linhas de cuidado definidas no PCDT. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) não padronizou para o elenco do CEAF o medicamento Clobazam. Logo, tal medicamento não é fornecido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, através do CEAF.**

* Levetiracetam 100mg/mL é disponibilizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF8), aos pacientes que se enquadrem nos critérios de inclusão Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Epilepsia e conforme o disposto na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e na Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelecem as normas de financiamento e de execução do CEAF no âmbito do SUS.

(...)

13. Para o tratamento da Epilepsia, o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Epilepsia (tal PCDT encontra-se em atualização pela Comissão Nacional de Incorporação de tecnologias no SUS). Por conseguinte, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), atualmente, disponibiliza, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), os seguintes medicamentos: Gabapentina 300mg e 400mg (cápsula), Vigabatrina 500mg (comprimido), Lamotrigina 100mg (comprimido), Levetiracetam 100mg/mL (solução oral) e Topiramato 25mg, 50mg e 100mg (comprimido).

Nesses termos, a respeito do Clobazam, verifica-se que se trata de medicamento já incluído no PCDT para epilepsia, integrando o grupo 2, contudo, a Secretaria de Estado de Saúde ainda não providenciou a padronização para o elenco do CEAF.

Ademais, conforme disposto no art. 49 do Título IV da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelece as normas de execução do CEAF no âmbito do SUS, cabe às Secretarias de Saúde dos Estados a programação, aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos que compõem o grupo 2, desde que garantidas as linhas de cuidado definidas no PCDT.

Acerca do periculum in mora, o questionário médico respondido pela profissional da rede pública de saúde informa que "caso descontinue o tratamento, pode levar a descontrole das crises convulsivas e risco de morte" (ev. 1, anexo2, fl. 17).

Para análise da Oxcarbazepina, reporto-me ao parecer do NAT acostado, na data de 29/09/2023, aos autos de nº 5093960-47.2023.4.02.5101, que tramita na 5ª VF do Rio de Janeiro (ev. 7 daqueles autos):

1. Informa-se que o medicamento Oxcarbazepina está indicado em bula para tratamento do quadro clínico apresentado pela Autora - epilepsia, conforme relatado em documento médico.

2. No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado insta mencionar que Oxcarbazepina não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.

3. O medicamento Oxcarbazepina possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), contudo até o momento não foi analisado pela da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (CONITEC-MS).

4. Para o tratamento da epilepsia, o Ministério da Saúde publicou a Portaria Conjunta SCTIE/SAS/MS no 17, de 21 de junho de 2018, a qual dispõe sobre o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Epilepsia (tal PCDT foi atualizado pela Comissão Nacional de Incorporação de tecnologias no SUS (Conitec), porém ainda não foi publicado). Por conseguinte, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) disponibiliza, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), os seguintes medicamentos: Gabapentina 300mg e 400mg (cápsula), Vigabatrina 500mg (comprimido), Lamotrigina 100mg (comprimido), Levetiracetam 100mg/mL (solução oral); 250mg e 750mg (comprimido) e Topiramato 25mg, 50mg e 100mg (comprimido). No âmbito da Atenção Básica, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, conforme relação municipal de medicamentos (REMUME-Rio) disponibiliza: Ácido Valproico 250mg e 500mg (comprimido) e 250mg/5mL (xarope), Carbamazepina 200mg (comprimido) e 20mg/mL (solução oral), Fenitoína 100mg (comprimido), Fenobarbital 100mg (comprimido) e 40mg/mL (solução oral), Valproato de Sódio 250mg/5mL (xarope).

5. **Cabe ressaltar ainda que o PCDT faz referência a Oxcarbazepina, mencionando que este medicamento não está indicado neste Protocolo, visto não possuir vantagens terapêuticas em relação aos demais agentes constantes no elenco de medicamentos disponíveis. O único estudo com evidência classe I no tratamento de crises focais em crianças, o fármaco foi comparado à fenitoína. A literatura carece de estudos comparativos entre a oxcarbazepina e a carbamazepina, que é considerada fármaco de primeira escolha para tratamento desse nicho de pacientes.**

No tocante aos tratamentos disponibilizados, a médica assistente destacou que o paciente já fez uso de ácido valproico, porém não houve resposta adequada. Diz também que não há indicação de Fenitoína, Fenobarbital, Vigabatrina, Lamotrigina ou Gabapentina, pois são drogas que "não constituem primeira ou segunda opção terapêuticas para o tipo de epilepsia apresentada, portanto, não indicadas previamente" (ev. 1, anexo2, fl. 12).

Quanto Levetiracetam e Carbamazepina, afirma:

Há possibilidade de troca por outras medicações oferecidas pelo SUS como levetiracetam, carbamazepina, mas com possibilidade de retorno de crises no momento da troca, não resposta terapêutica (com retorno de crises que, no momento, estão controladas) e efeitos colaterais não presentes como uso atual de oxcarbazepina e clobazam.

Na hipótese, observo que a justificativa para não uso da Carbamazepina, alternativa presente no SUS, é meramente hipotética, pois o laudo menciona a possibilidade de retorno das crises no momento da troca, sem fundamentar a pretensa superioridade terapêutica deste em relação àquele.

Quanto à comparação entre Carbamazepina e Oxcarbazepina, vale ressaltar o que o NAT informa, no parecer acima, que o PCDT faz referência ao segundo fármaco, mencionando que não está indicado no Protocolo porque não possui vantagens terapêuticas em relação aos demais agentes disponíveis.

O órgão técnico pondera que a literatura carece de estudos comparativos entre a Oxcarbazepina e a Carbamazepina, sendo esta considerada fármaco de primeira escolha para tratamento desse nicho de pacientes.

Ainda, o Núcleo salienta que no único estudo com evidência classe I no tratamento de crises focais em crianças, a Oxcarbazepina foi comparada à Fenitoína, que é disponibilizada pelo REMUME-Rio.

Nesse contexto, conclui-se que a parte autora não esgotou as opções terapêuticas do SUS, não demonstrando satisfatoriamente a inviabilidade dessas alternativas em relação à Oxcarbazepina.

Finalmente, **acerca do pedido de fornecimento de fraldas**, o Enunciado nº 10 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabeleceu que "o cumprimento de pleitos judiciais que visem à prestação de ações ou serviços exclusivos da assistência social não devem ser impostos ao Sistema Único de Saúde - SUS".

Nesse sentido, não há como se obrigar os réus ao fornecimento do mencionado insumo, sendo certo que a parte autora pode usufruir dos benefícios instituídos pelo Programa Farmácia Popular, havendo nos autos expressa referência a tal condição (ev. 1, anexo2, fl. 38).

Por essas razões, **DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar que as rés forneçam o medicamento CLOBAZAM, na forma e quantidade indicada pela médica assistente (ev. 1, anexo2, fl. 20), devendo a entrega ser condicionada à apresentação de relatório médico atualizado a cada 3 (três) meses, ante a necessidade de reavaliação periódica do quadro. **Prazo: 15 dias.**

Intimem-se para cumprimento, em caráter urgente.

A despeito da solidariedade entre os réus, **direciono o cumprimento do julgado, em primeiro lugar, ao Estado do Rio de Janeiro**, conforme tese fixada pelo STF no RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Tema nº 793), haja vista ser responsável por gerir o Componente Especializado em Assistência Farmacêutica do SUS, sobre o qual deve recair, prioritariamente, a obrigação de fornecimento do medicamento postulado.

Eventual impossibilidade de proceder ao cumprimento da tutela de urgência no prazo acima descrito deverá ser noticiada nos autos, não isentando o ente público de demonstrar, no mínimo, as providências até então adotadas para a aquisição.

1- Considerando-se que não há, em princípio, necessidade de designação de audiência, **citem-se os réus** para, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 9º da Lei nº 10.259/01), apresentarem contestação, bem como se manifestarem sobre eventual proposta de acordo.

No mesmo prazo, deverão apresentar toda documentação de que disponham para esclarecimento da causa (art. 11 da Lei nº 10.259/01).

2 - Alegando os réus fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou em caso de juntada de novos documentos, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias."

Sustenta o Recorrente que, em razão da falta de controle esfinteriano decorrente de suas patologias, precisa fazer uso diário de 5 fraldas tamanho P adulto.

Argumenta não se tratar de insumo de assistência social, mas de insumo necessário ao tratamento de saúde e que, nos termos da PORTARIA GM/MS Nº 2.898, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012, o Programa Farmácia Popular não disponibiliza as fraldas gratuitamente, mas sim a preços reduzidos e em quantidade insuficiente.

Pontua que a família é hipossuficiente, não tendo condições de custear a compra das fraldas.

Liminar deferida - evento 3, DESPADEC1.

Informação do Estado do Rio de Janeiro de que as fraldas pediátricas estão disponíveis em estoque para retirada - evento 9, OFIC1.

VOTO

Considerando a manutenção do quadro fático nos autos originários, mantenho as razões de decidir do indeferimento da liminar, as quais reproduzo abaixo:

Narra o Autor, 5 anos de idade, apresentar características do Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas não preencher os critérios DSM-V, tendo sido diagnosticado com mielomeningocele, hidrocefalia, bexiga neurogênica e epilepsia focal, além de depender de terceiros para se locomover e realizar outras atividades. Atualmente, encontra-se em tratamento no Instituto de Puericultura Martagão Gesteira, sendo prescritos os medicamentos CLOBAZAM (FRISIUM - 10MG) e OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL - 60MG/ML)(evento 1, ANEXO2, fl. 12).

Ainda, em razão da falta de controle esfinceteriano, precisa fazer uso de 5 FRALDAS por dia, no tamanho P adulto (evento 1, ANEXO2, fls. 13/14).

Serviço: Neuropediatria

Data: 29/05/2024

Paciente: Isaque Fernandes Peres

Prontuário: 121907

RELATÓRIO MÉDICO

Declaro com consentimento dos responsáveis que o paciente acima foi avaliado no serviço de Neuropediatria do IPPMG-UFRJ apresentando características de Transtorno do Espectro Autista, porém não preenchendo critérios conforme DSM-V.

Além disso, apresenta alterações em seu exame neurológico consequentes a mielomeningocele e hidrocefalia (portador de derivação ventrículo-peritoneal), sendo dependente de terceiros para sua locomoção e outras atividades. Apresenta também bexiga neurogênica e epilepsia focal, no momento fazendo uso de oxcarbazepina 60mg/ml, 7ml de 12/12h, além de Clobazam 10mg/noite.

Como tratamento, deve manter acompanhamento regular e contínuo, por tempo indeterminado, com terapias multidisciplinares, tais como fonoaudiologia, terapia ocupacional, e psicologia, visando seu melhor desenvolvimento neuropsicomotor e das habilidades necessárias para realização de atividades de vida diária. Suas terapias devem preferencialmente situar-se no mesmo local, considerando suas limitações cognitivo-comportamentais e sensoriais em situações de estresse como transporte e locais públicos.

O paciente não possui controle esfinceteriano e por isso faz uso de fraldas tamanho P de adulto, 5 unidades/dia ou 150 unidades/mês.

Além disso, deve frequentar escola regular, com mediador e sala de recursos, objetivando melhorar a adesão às atividades propostas e integração ao ambiente, com o suporte psicopedagógico adequado ao seu caso.

Dra. Vivian Mendes Gomes
Neuropediatria
CRM 52390/0-0

Ana Paula R. Lima
MÉDICA
CRM 32.0110496-2

A disposição para esclarecimentos,

CID10: F84.0/ Q07.0/ Q05/ N31.9 / G40.0

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA

AMBULATÓRIO: NEUROLOGIA DATA: 29 / 05 / 2014

OME: Jaqueline Ferreira Alves

PRONTUÁRIO: 121907

DIAGNÓSTICO: Mielomeningocele e hidrocefalia e distúrbio do trato urinário e epilepsia.

PACIENTE NÃO TEM CONTROLE DE ESFÍNCTERES URINÁRIO E NAL NECESSITA DE:

FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P
5 / DIA 150 / MÊS.

CID F84.0 / Q07.0 / N31.9 / G40.0

Assinatura e Carimbo do Médico

Pretende a concessão da tutela provisória de urgência para "que os réus, solidariamente, propiciem as condições necessárias para a melhora da parte autora, obrigando-os a fornecer os medicamentos CLOBAZAM e OXCARBAZEPINA e o insumo FRALDAS DESCARTÁVEIS, nas doses e pelo tempo que se fizer necessário."

De acordo com parecer do NAT, as fraldas são incorporadas à saúde como um dos insumos necessários à prática do cuidado e, na hipótese em tela, estão indicadas e são necessárias ao manejo do quadro clínico do Autor. Entretanto, não são disponibilizadas pelo SUS, não havendo outro insumo que possa ser considerado alternativa terapêutica.

7. As **incontinências** geram para a população sérios danos biopsicossociais, principalmente nas mulheres e idosos que são os públicos mais afetados. A prevalência de pessoas com incontinência urinária no mundo é de aproximadamente 5% da população. Estima-se que na população brasileira cerca de 10 milhões de pessoas sofram de incontinência. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstram que a incidência é maior nas mulheres. Com a finalidade de absorver e conter o fluxo miccional e/ou anal, as **fraldas** são tecnologias incorporadas à saúde como um dos insumos necessários à prática do cuidado⁷.

III – CONCLUSÃO

1. Em síntese, trata-se de Autor portador de **mielomeningocele, hidrocefalia, bexiga neurogênica e epilepsia focal** (Evento 1 ANEXO2, Páginas 12 a 21), solicitando o fornecimento dos medicamentos **Clobazam e Oxcarbazepina** e do insumo **fralda descartável** (tamanho P) - Evento 1, INICI, Página 8.

2. Elucida-se que as **disfunções miccionais e do intestino são comuns em crianças com transtorno do espectro autista (TEA)**¹³. A disfunção miccional infantil ocorre por uma coordenação vesico-esfincteriana, promovendo alterações urodinâmicas importantes e comprometendo o esvaziamento da bexiga. Os distúrbios miccionais da infância podem acometer as crianças em todas

as idades. Segundo a atual classificação da International Children's Continence Society (ICCS), tais distúrbios podem envolver as diferentes fases da micção, causando prejuízo na fase de enchimento ou de esvaziamento da bexiga¹⁴.

3. Destaca-se que o insumo **fralda descartável** (tamanho P) **está indicado e é necessário** ao manejo do quadro clínico do Autor - mielomeningocele, hidrocefalia, bexiga neurogênica e epilepsia focal (Evento 1 ANEXO2, Páginas 12 a 21). Contudo, **não se encontra disponibilizado** no SUS, pela via administrativa, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro, **bem como não foi identificado outro insumo que possa configurar alternativa**.

Pois bem.

Entendo que as fraldas descartáveis encontram-se justificadas em razão da ausência de controle esfincteriano e, conforme parecer do NAT, além de indicadas, são necessárias ao manejo do quadro clínico. Ademais, o insumo contribui para uma melhor qualidade de vida e existência digna, objetivo central da Lei nº 8.080/1990.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos.

3. O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite

especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.

4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccígea e trocantérica.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.498.607/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019.)

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO para que os Réus, dentro de suas esferas de competências e observado o tema 793 do STF, forneçam ao Autor fraldas descartáveis adulto tamanho P, conforme prescrição médica do evento 1, ANEXO2, fl. 14). Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.

5076383-22.2024.4.02.5101

510014666162 .V3